



중·고령 성인의 사회적 고립과 외로움의 중단적 관계: 자기통제력의 매개효과

Longitudinal Relationship Between Social Isolation and Loneliness in Middle-Aged and Older Adults: Mediating Effects of Self-Control



서수정, 이승철, 김혜민, 노수림†

충남대학교 심리학과, smoh@cnu.ac.kr

서론

- 외로움과 사회적 고립은 현대 사회의 주요 공중보건 위험요인으로, WHO (2023)는 이를 심혈관질환, 비만, 흡연에 준하는 건강 위험 요인으로 규정하였다(Dahlberg et al., 2024).
- 국내에서도 사회적 고립도가 2019년 27.7%에서 2023년 33.0%로 상승하고, 1인 가구 비율이 34.5%에 이르는 등 고립이 심화되고 있다(통계청, 2024). 이러한 변화는 단순한 관계 결핍을 넘어 우울, 불안, 자살사고 등 심리적 건강 악화로 이어질 수 있다(Holt-Lunstad et al., 2022; 김진희, 2024).
- 외로움은 개인이 기대하는 사회적 관계와 실제 경험 간의 불일치에서 비롯되는 주관적 정서 반응으로(da Silva, 2025), 객관적 관계 결핍을 의미하는 사회적 고립과 구별된다.

- 특히 중·고령층에서 외로움은 삶의 질 저하, 건강 불평등, 인지기능 저하 등과 밀접하게 관련되며, 중단 연구에서도 65세 이상 고령자의 외로움 취약성이 반복적으로 보고되고 있다(Dahlberg et al., 2024).
- 또한, 동일한 사회적 고립 수준에서도 외로움의 정도는 개인의 심리적 자원에 따라 달라질 수 있다. 그중 자기통제력은 충동 억제와 정서 조절을 통해 관계의 질을 유지하고, 고립의 부정적 영향을 완충하는 핵심 보호 요인으로 작용한다는 결과들이 보고되었다(Tangney et al., 2004; 노수림 외, 2024).
- 이에 본 연구는 한국 중·고령 성인을 대상으로 사회적 고립이 시간 경과에 따른 외로움 변화를 어떻게 예측하는지, 그리고 이 관계에서 자기통제력이 어떤 매개적 역할을 하는지를 중단적으로 검증하고자 한다.

연구 방법

❖ 참가자 정보

- 본 연구는 국내 41-71세 중·고령 성인 298명의 반복측정 종단자료를 분석한 연구로, 연구 대상자들은 2022년 2월부터 6개월 간격으로 총 3회에 걸쳐 설문에 응답함.

표 1. 주요 변인의 기술통계량

변인	측정 시점(T)	M (SD)	Cronbach's α
외로움	1시점(T1)	2.27 (2.11)	.78
	2시점(T2)	2.42 (2.36)	.89
	3시점(T3)	2.63 (2.32)	.88
사회적고립	1시점(T1)	30.05 (8.20)	.75
자기통제력	1시점(T1)	39.17 (6.38)	.85

❖ 분석방법

- 본 연구의 분석에는 R (ver. 4.3.2)과 psych, lme4, lmerTest, emmeans, 그리고 Rmeditation 패키지를 활용함.
- 1시점의 사회적 고립과 자기통제력으로 동 시점의 외로움과 외로움의 3시점에 걸친 변화량을 추정하기 위해, 선형 혼합 효과 모형(Linear Mixed Effect Model, LMM)으로 개별 계수를 추정함.
- 이후 매개효과를 검증하기 위해, 개별 계수로 간접효과를 계산하고 Monte Carlo 방식의 Bootstrapping (5,000회)으로 95% 신뢰구간을 확인하여 통계적 유의성을 확인함.

❖ 측정 도구

- 외로움(UCLA) : 한국판 단축형 3문항 UCLA 외로움 척도(Russell, Peplau, & Cutrona, 1980; 진은주·황성현, 2019)로 측정함. 응답은 '0=전혀 그렇지 않다~4=항상 그렇다'의 4점 Likert 척도로 구성되며, 점수가 높을수록 외로움 정도가 심하다는 것을 의미함.
- 사회적 고립(LSNS) : 한국판 Lubben 사회적 연결 척도를 활용함(Lubben, 1988; 이경호·이명선·윤현숙, 2009). 총 10문항으로 구성되어 있으며, 가족 및 친구 관계의 양과 질을 묻는 10개 문항으로 구성됨. 개별 문항은 0-5점으로 계산되며, 값이 클수록 사회적 고립이 낮음을 의미함.
- 자기통제력(BSCS) : 한국판 단축형 자기통제력 척도(Lubben, 1988; 이경호·이명선·윤현숙, 2009)를 사용함. 총 11문항, '1=전혀 그렇지 않다~5=매우 그렇다'의 5점 Likert 척도로 구성되어 있고 점수가 높을수록 스스로 내면의 반응을 참거나, 바람직하지 않은 행동을 억제하는 능력이 높다는 것을 의미함.

연구 결과

◆ 상관계수 결과

표 2. 주요 변인 간 상관

	1	2	3	4
1. 외로움(T1)	-			
2. 외로움(T2)	.51***	-		
3. 외로움(T3)	.47***	.60***	-	
4. 사회적고립 (T3)	-.40***	-.35***	-.40***	-
5. 자기통제력 (T1)	-.43***	-.29***	-.27***	.38***

***p < .01, **p < .001

◆ 매개효과 분석 결과

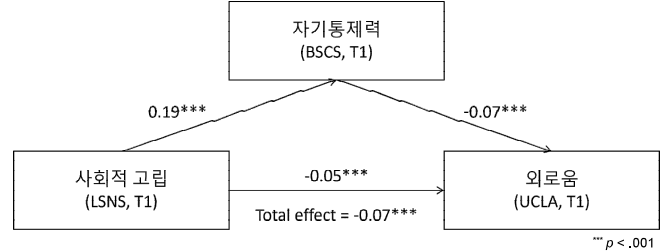
- 두 모형 모두 간접효과 95% 신뢰구간에 0을 포함하지 않아, 통계적으로 유의함이 확인됨.

표 3. 모형 1, 2의 간접효과 유의성 검증 결과

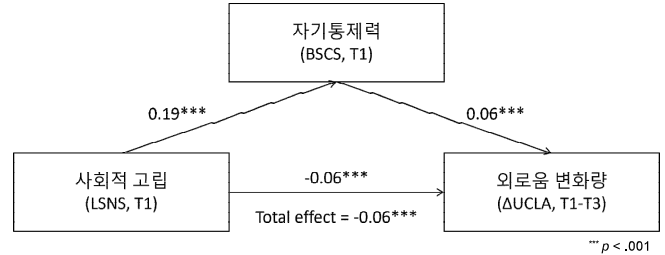
	Estimate	Boot SE	95% CI	
			LLCI	ULCI
모형1. 사회적 고립(T1) → 자기통제력(T1) → 외로움(T1)				
간접효과	-0.013	0.015	-0.023	-0.005
모형2. 사회적 고립(T1) → 자기통제력(T1) → 외로움 변화량(T1-T3)				
간접효과	0.011	0.005	0.003	0.022

◆ 개별 경로 계수 확인

① 모형1. 사회적 고립(T1) → 자기통제력(T1) → 외로움(T1)



② 모형2. 사회적 고립(T1) → 자기통제력(T1) → 외로움 변화량(T1-T3)



논의 및 결론

- 본 연구는 국내 중·고령 성인의 사회적 고립이 외로움에 영향을 미칠 뿐 아니라, 시간에 따른 외로움의 증가를 가속시키는 위험 요인임을 확인하였다.
- 자기통제력은 사회적 고립이 외로움으로 이어지는 과정에서 정서적 반응을 조절하고, 고립의 부정적 영향을 완화하는 내적 보호 요인으로 작용하였다.
- 다만, 자기통제력 수준이 높을수록 시간에 따른 외로움의 변화량을 증가시킨다는 결과도 확인되었다. 이는 동일 시점의 데이터를 사용하여 분석할 때와는 상반된 결과이며, 이러한 결과가 나타난 것은 자기통제력이 일정 수준을 넘어서면 정서 억제와 관계의 경직성을 초래하여 사회적 신호에 대한 민감성과 정서적 공유가 감소하기 때문으로 해석된다.
- 향후 중·고령자 대상 외로움 예방 및 개입 전략 계획 시 사회적 관계망 강화와 자기통제력 증진을 통한 심리사회적 접근을 고려하되, 과한 자기통제력으로 인한 정서적 경직성과 대인관계 단절에 유의할 필요가 있다.

참고문헌

- 김진희, (2024). 외로움과 사회적 고립: 정신건강상태에 따른 유형분석. 한국과 세계, 6(6), 527-551.
- 노수림, 최원일, 김주현, (2024). 중·고령 성인의 자기통제력이 외로움에 미치는 영향: 사회적 배제와 좌절된 소속감의 매개효과. 한국 심리학회지: 건강, 29(1), 127-156.
- Cudjoe, T. K. M., Kotwal, A. A., et al. (2020). The impact of social isolation on older adults: A systematic review. The Gerontologist, 60(4), e50-e66.
- Dahlberg, L., von Saenger, I., Naseer, M., Lennartsson, C., & Agahi, N. (2024). National trends in loneliness and social isolation in older adults: an examination of subgroup trends over three decades in Sweden. Frontiers in Public Health, 12, 1444990.
- da Silva, T. M. H. R., (2025). Exploring loneliness: conceptualisation and impact in older adults. British Journal of Community Nursing, 30(4), 188-195.
- Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review. Perspectives on Psychological Science: A Journal of the Association for Psychological Science, 10(2), 227-237.
- Russell, D., Peplau, L. A., & Ferguson, M. L. (1978). Developing a Measure of Loneliness. Journal of Personality Assessment, 42(3), 290-294.
- Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271-324.